

Cykl *samopodtrzymujący się*

Restrykcja → głód → utrata kontroli → wstyd → kompensacja → silniejsza restrykcja. Każdy element karmi następny. Kompensacja nie rozwiązuje — wzmacnia cykl.

CZAS: 15 min · psychoedukacja Sesja 1-2 · po modelu transdiagnostycznym

ŹRÓDŁO: Fairburn (2008); Polivy & Herman (1985, „*Dieting and bingeing*”)

JAK UŻYWAĆ

Zobacz **siedem etapów cyklu** (sekcja 1), zrozum **dlaczego kompensacja podtrzymuje** a nie rozwiązuje (sekcja 2). W sekcji 3 znajdziesz **punkty interwencji** w cyklu. Sekcja 4 — Twoja własna mapa.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Polivy & Herman (1985) jako pierwsi opisali *dietary restraint theory*: restrykcja żywieniowa jest **głównym predyktorem** epizodów objadania. To nie „*brak silnej woli*” prowadzi do epizodu — to *biologiczna deprywacja + psychologiczna „pokusa zakazanego owocu”*. Mózg pozbawiony jedzenia uruchamia silne sygnały głodu, a sztywne reguły („*nie wolno X*”) tworzą psychologiczną presję, która eskaluje. Złamanie jednej reguły aktywuje myślenie *wszystko-albo-nic*: „*już zjadłem/-am ciastko, dzień zepsuty, mogę zjeść wszystko*”. Fairburn (2008): każdy element cyklu **karmi następny**. Wymioty nie „*cofają*” epizodu — usuwają tylko 30–50% przyjętych kalorii (Kaye 1993), ale 100% wzmacniają restrykcję, która wywoła kolejny epizod. To **pułapka**: im więcej kompensacji, tym silniejsza pętla. Wyjście — przerwanie cyklu w jego początku (restrykcji), nie w końcu (kompensacji).

01 📄 Siedem etapów cyklu

1. Restrykcja — głodówka, reguły „*zakazanych*” jedzeń → **2. Głód biologiczny + psychologiczny** — sygnały z mózgu i ciała → **3. Złamanie reguły** — myślenie *wszystko-albo-nic* → **4. Epizod objadania** — utrata kontroli (*loss of control*) → **5. Wstyd i lęk o wagę** → **6. Kompensacja** — wymioty, środki, ćwiczenia, głodówka → **7. Powrót do restrykcji** (silniej, jako „*kara*” za epizod) → powrót do 1.

02 🕒 Dlaczego kompensacja nie rozwiązuje

WYMIOTY

Usuwa się tylko **30-50% kalorii** (Kaye 1993). Reszta wchłaniana jest szybko. Ale: erozja zębów, zaburzenia elektrolitowe, ryzyko arytmii — pełne konsekwencje.

ŚRODKI PRZECZYSZCZAJĄCE

Działają na *jelito grube* — kalorie są wchłaniane wcześniej (jelito cienkie). Utrata wagi po laksatywach = woda. Trwałe uszkodzenia jelita.

ĆWICZENIA KOMPENSACYJNE

Wykonywane „*żeby spalić epizod*” — wzmacniają cykl. Inaczej niż ćwiczenia rekreacyjne. Często z przymusem, w tajemnicy, rany i kontuzje.

KOLEJNA GŁODÓWKA

„*Jutro nic nie zjem*” — głównym efektem jest przygotowanie pod **następny** epizod. Biologiczny głód jest silniejszy niż silna wola.

Wspólny mechanizm: wszystkie kompensacje dają *chwilową* ulgę psychologiczną („*cofnąłem/-am to*”), ale **wzmacniają** restrykcję, która prowadzi do kolejnego epizodu. To **pozytywne wzmocnienie** dysfunkcyjnego wzorca — każdy „*sukces*” kompensacji uczy mózg, że **warto** to powtarzać.

03 Punkty interwencji w cyklu

Każdy z siedmiu etapów cyklu jest **potencjalnym miejscem interwencji**. CBT-E celuje w kilka z nich jednocześnie — najmocniejszy efekt daje praca na *początku* cyklu (etapy 1–3), nie na końcu (6–7).

ETAP 1: REGULARNE JEDZENIE

Najsilniejsza interwencja CBT-E. Trzy posiłki + 2–3 przekąski w stałych porach. Zatrzymuje cykl u źródła.

ETAP 2: DZIENNIK ŻYWIENIOWY

Świadomość głodu i sytości. Mapowanie wzorca. Pomaga rozpoznać moment, gdy restrykcja przechodzi w głód.

ETAP 3: PRACA Z REGUŁAMI

Identyfikacja sztywnych reguł, restrukturyzacja myślenia *wszystko-albo-nic*, eksperymenty behawioralne.

ETAP 4–5: PLAN AWARYJNY

Co zrobić w momencie epizodu i tuż po. Tolerancja dystresu, kontakt z osobą wsparcia, redukcja kompensacji.

ETAP 6–7: REDUKCJA KOMPENSACJI + PRZERWANIE POWROTU DO RESTRYKCJI

Kompensacja to *nie* błąd, który trzeba naprawić, lecz *część cyklu*. Po epizodzie — bez kompensacji, bez głodówki „na pokutę”, powrót do regularnego jedzenia w następnym planowanym posiłku.

04 Moja mapa cyklu

OD CZEGO SIĘ U MNIE ZACZYNA

— restrykcja, stres, emocje, samotność, konkretna sytuacja

MÓJ PUNKT INTERWENCJI DO PIERWSZEJ PRACY

— który etap chcę zaadresować najpierw; od najwcześniejszego

-------------	-------------

Klucz: cykl bulimii nie jest „karą za słabość” — to **logiczna konsekwencja** biologii i psychologii. Każdy element cyklu ma *swój powód*: restrykcja jako próba kontroli, głód jako sygnał ciała, epizod jako biologiczna reakcja, kompensacja jako próba „cofnięcia”. Mózg nie odróżnia restrykcji terapeutycznej od głodówki — reaguje *identycznie*: spowolnieniem metabolizmu, podwyższoną reaktywnością na sygnały jedzenia, obsesyjnymi myślami o jedzeniu. Polivy & Herman (1985, badanie z 84 osobami): grupy z restrykcją żywieniową zjadały **3x więcej** w sytuacji „złamania reguły” niż grupy bez restrykcji. To *nie* brak silnej woli — to fizjologia. Wyjście: **regularne jedzenie** (3 posiłki + 2–3 przekąski) jako fundament CBT-E. To nie diet — to *antidotum* na restrykcję.